

KlinikIQ General Surgery Ultra Refined QC Report

Bu rapor, Genel Cerrahi standart vakalarının kapsam, veri temizliği, seçenek/feedback yeniden yazımı ve teknik doğrulama sonuçlarını özetler.

QC maddesi	Sonuç
Toplam taranan Genel Cerrahi vaka sayısı	27
Güncellenen Genel Cerrahi vaka sayısı	27
Sol kolon metni yeniden yazılan vaka sayısı	27
Cerrahi alt alanı netleştirilen vaka sayısı	27
Vital/fizik muayene yorumu düzeltilen vaka sayısı	27
Objektif veri/tetkik alanı düzeltilen vaka sayısı	27
Olgu/tetkik katmanı kapsamı artırılan vaka sayısı	26
Laboratuvar/görüntüleme/mikrobiyoloji/patoloji katmanı ayrımı düzeltilen vaka sayısı	27
Görüntüleme/görsel açıklaması güçlendirilen vaka sayısı	24
Kolon kayması/referans-durum/birim hatası düzeltilen satır sayısı	123
Alakasız/generic kısa yorum temizlenen vaka sayısı	26
Kısa yorum sıfırdan yazılan kayıt sayısı	65
Gereksiz kısa yorum kaldırılan/gizlenen kayıt sayısı	65
Alakasız tetkik kaldırılan/gizlenen kayıt sayısı	67
Soru kökü güncellenen vaka sayısı	27
Seçenek seti güçlendirilen vaka sayısı	27
Seçenek metni değiştirilen sayı	87
OptionFeedback sıfırdan yazılan sayı	135
Klinik/Bilimsel gerekçe yeniden yazılan vaka sayısı	27
Kanıt zinciri yeniden yazılan vaka sayısı	27
Sınav notu/Core Knowledge/Exam Pearl güçlendirilen vaka sayısı	27
Scientific concern sayısı	0
ID değişikliği	Yok
Doğru cevap mantığı	Korundu
TUS Spot Olgular	Dokunulmadı
Build/test durumu	JS syntax check passed; ES module import passed; Vite build not completed because node_modules was absent and npm install timed out, then npm run build failed with vite: not found.

Temizlenen Başlıca Hata Tipleri

- Kolanjit/kolesistit kartlarından beta-hCG ve gebelik yorumları kaldırıldı.
- Kolanjit/kolesistit USG kartlarındaki apandisit yorum kaçakları temizlendi.
- Travma, perforasyon, nekrotizan enfeksiyon ve üst GIS vakalarındaki menenjit/pnömoni/hiperkalemi/nefrotik sendrom gibi başka vaka yorumları temizlendi.
- Görüntülemelerde "Modaliteye özgü bulgu" gibi boş referanslar klinik karar anlamı taşıyan satırlara dönüştürüldü.
- "Bu olguda en uygun yanıt değildir" kalıbı Genel Cerrahi optionFeedback alanlarından kaldırıldı.
- Kanıt zincirleri üç tam cümleli, gerçek vaka ipuçlarına dayanan ve cerrahi karara bağlanan yapıya getirildi.

Kaynak Kontrolü / Cerrahi Karar Önceliği Kontrolü

v163-new-006-sag-alt-kadran-agrisi - Sağ alt kadran ağrısı: Akut apandisit

Karar kuralı: Sağ alt kadran ağrısı sorularında göç eden ağrı + McBurney/rebound + komprese olmayan geniş apendiks üçlüsü akut apandisiti güçlü biçimde destekler.

- Ağrının periumbilikal bölgeden sağ alt kadrana göç etmesi apandisit tipik visseral-somatik ağrı geçişini düşündürür.
- McBurney hassasiyeti, lokal rebound ve defans sağ alt kadranda lokal periton irritasyonunu gösterir.
- USG'de komprese olmayan 8 mm apendiks görülmesi inflamasyonun anatomik kanıtıdır.

v167-new-047-ates-ve-sag-ust-kadran-agrisi - Ateş ve sağ üst kadran ağrısı: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile safra yolu drenajı

Karar kuralı: Kolanjitte MRCP tanısal olabilir, kolesistektomi nüksü önler; fakat sepsis riski olan obstrükte safra yolunda acil karar ERCP ile drenajdır.

- Ateş-titrete, sağ üst kadran ağrısı ve skleral ikter birlikteliği Charcot triadı ile akut kolanjiti düşündürür.
- Direkt bilirubin, ALP ve GGT yüksekliği biliyer obstrüksiyonla uyumlu kolestatik laboratuvar paternini gösterir.
- Ultrasonografide dilate koledok ve distal koledok taşı görülmesi, enfekte safra yolunda drenaj gerektiren mekanik tıkanıklığı ortaya koyar.

v168-new-059-ates-ve-sarilikla-basvuran-hasta - Ateş ve sarılıkla başvuran hasta: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile biliyer drenaj

Karar kuralı: Kolanjitte hipotansiyon veya konfüzyon varsa soru genellikle ağır kolanjit ve acil ERCP drenajı kararını sorgular; MRCP beklemek kaynak kontrolünü geciktirir.

- Ateş, sağ üst kadran ağrısı ve sarılık akut kolanjitin temel klinik örüntüsünü oluşturur.
- Hipotansiyon ve konfüzyon ağır kolanjit ve sepsis riski açısından acil drenaj gerektiren sistemik etkilenimi gösterir.
- USG'de koledok dilatasyonu ve distal taş görülmesi enfekte obstrüksiyonun biliyer drenajla kontrol edilmesi gerektiğini gösterir.

v172-new-074-siddetli-karin-agrisi-ve-atriyal-fibrilasyon - Şiddetli karın ağrısı ve atriyal fibrilasyon: Kontrastlı BT anjiyografi

Karar kuralı: "Pain out of proportion" + atriyal fibrilasyon + laktat/asidoz varsa kontrastlı BT anjiyografi düşün; peritonit gelişirse tanıyla birlikte acil cerrahi gündeme gelir.

- Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı embolik mezenter arter tıkanıklığı riskini artırır.
- Ani başlayan, muayene bulgusuna göre orantısız şiddetli karın ağrısı akut mezenter iskemi için tipiktir.
- Laktat yüksekliği ve metabolik asidoz bağırsak hipoperfüzyonu olasılığını destekler ve vasküler görüntüleme gerektirir.

v173-new-086-yasli-hastada-mekanik-obstruksiyon - Yaşlı hastada mekanik obstrüksiyon: Safra taşı ileusu

Karar kuralı: Yaşlı kadın + safra taşı öyküsü + ince barsak obstrüksiyonu + pnömobilia varsa safra taşı ileusunu düşün.

- Yaşlı hastada safra taşı öyküsü ve mekanik obstrüksiyon bulguları birlikte bulunur.
- BT'de dilate ince barsak ansları mekanik ileusu gösterir.
- Pnömobilia ve ektopik safra taşı görülmesi kolesistoenterik fistül üzerinden gelişen safra taşı ileusunu destekler.

v174-new-093-travma-sonrasi-karin-hassasiyeti - Travma sonrası karın hassasiyeti: Acil eksploratif laparotomi yapılması

Karar kuralı: İnstabil + FAST pozitif = acil laparotomi; stabil + FAST/klinik şüphe = BT ile anatomik değerlendirme.

- Künt karın travması sonrası hipotansiyon ve taşikardi hemorajik şok düşündürür.
- FAST incelemede birden fazla alanda serbest sıvı görülmesi intraperitoneal kanama lehinedir.
- İnstabil travma hastasında BT beklemek cerrahi kanama kontrolünü geciktirir.

v174-new-094-sag-ust-kadran-agrisi - Sağ üst kadran ağrısı: Akut kolesistit

Karar kuralı: Sağ üst kadran ağrısı + ateş + Murphy + USG'de taş/duvar kalınlaşması/perikolesistik sıvı = akut kolesistit.

- Yağlı öğün sonrası başlayan ve saatlerce süren sağ üst kadran ağrısı safra kesesi kaynaklı inflamasyonu düşündürür.
- Pozitif Murphy bulgusu safra kesesi inflamasyonuna lokalize muayene bulgusudur.
- USG'de taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı akut kolesistitin anatomik kanıtını oluşturur.

v175-new-107-yumusak-doku-enfeksiyonunda-hizla-kotulesme - Yumuşak doku enfeksiyonunda hızla kötüleşme: Acil cerrahi eksplorasyon ve geniş debridman

Karar kuralı: Orantısız ağrı + hızlı yayılım + toksisite/krepitasyon varsa kültür veya görüntüleme beklenmeden acil debridman düşünülür.

- Diyabet zemininde küçük kesi sonrası enfeksiyonun saatler içinde hızla ilerlemesi nekrotizan enfeksiyon riskini artırır.
- Ağrının cilt bulgularına göre orantısız olması nekrotizan fasiit için kritik klinik ipucudur.
- Krepitasyon, yumuşak dokuda gaz ve laktat yüksekliği acil cerrahi debridman gerektiren ağır doku enfeksiyonunu destekler.

v176-new-120-diskilama-sonrasi-anal-agri - Dışkılama sonrası anal ağrı: Akut anal fissür

Karar kuralı: Dışkılama sırasında cam kesiği gibi ağrı + posterior orta hat lineer yırtık = anal fissür.

- Sert dışkılama sonrası başlayan cam kesiği tarzı ağrı akut anal fissür için tipiktir.
- Kanamanın az miktarda ve parlak kırmızı olması distal anorektal kaynakla uyumludur.
- Posterior orta hatta yüzeysel lineer yırtık görülmesi tanıyı doğrudan destekler.

v177-new-127-ani-bacak-agrisi-ve-soğukluk - Ani bacak ağrısı ve soğukluk: Acil sistemik heparinizasyon ve revaskülarizasyon için damar cerrahisi girişimi

Karar kuralı: 6P: pain, pallor, pulselessness, poikilothermia, paresthesia, paralysis; parestezi/paralizi varsa ekstremitte tehdit altındadır.

- Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülasyon embolik arter tıkanıklığı riskini artırır.
- Ani ağrı, solukluk, soğukluk ve distal nabız kaybı akut ekstremitte iskemisinin temel bulgularıdır.
- Duyu ve motor kayıp ekstremitenin tehdit altında olduğunu ve acil revaskülarizasyon gerektiğini gösterir.

v178-new-137-epigastrik-agri-ve-kusma - Epigastrik ağrı ve kusma: Agresif intravenöz sıvı replasmanı, analjezi ve yakın klinik izlem

Karar kuralı: Akut pankreatitte "hemen cerrahi" değil; erken sıvı ve analjezi. Biliyer obstrüksiyon/kolanjit varsa ERCP ayrı düşünülür.

- Sirta yayılan epigastrik ağrı ve öne eğilmekle rahatlama akut pankreatit için tipiktir.
- Serum lipazın belirgin yüksek olması tanıyı destekler.
- BUN yüksekliği ve hemokonsantrasyon hipovolemi riskini gösterdiği için erken sıvı tedavisini öncelikli yapar.

v183-new-190-kasik-sisligi-ve-kusma - Kasık şişliği ve kusma: Acil cerrahi değerlendirme ve operatif onarım

Karar kuralı: Redükte edilemeyen ağrılı fıtık + kusma/gaz çıkaramama = strangülasyon riski; zorlayıcı redüksiyondan kaçın.

- Ağrılı kasık kitlesinin artık redükte edilememesi inkarsere fıtığı gösterir.
- Kusma, gaz çıkaramama ve distansiyon mekanik obstrüksiyon geliştiğini destekler.
- Cilt eritemi, laktat yüksekliği ve taşikardi strangülasyon riskini düşündürür.

v184-new-194-sag-ust-kadran-agrisi - Sağ üst kadran ağrısı: Akut kolesistit

Karar kuralı: Murphy + taş + duvar kalınlaşması/perikolesistik sıvı = akut kolesistit; ikter ve koledok dilatasyonu varsa kolanjit/koledok taşı düşün.

- Sağ üst kadran ağrısının uzaması ve sağ omuza yayılması safra kesesi kaynaklı inflamasyonu düşündürür.
- Pozitif Murphy bulgusu safra kesesi inflamasyonu için lokalize muayene bulgusudur.

- USG’de taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı akut kolesistiti destekler.

v185-new-222-ani-sirt-agrisi-ve-hipotansiyon - Ani sırt ağrısı ve hipotansiyon: Hemodinamik resüsitasyonla eş zamanlı acil damar cerrahisi onarımı

Karar kuralı: Yaşlı erkek + sigara/HT + ani sırt-karın ağrısı + hipotansiyon + pulsatil kitle = rüptüre AAA; acil onarım.

- Hipertansiyon ve sigara öyküsü AAA riskini artırır.
- Ani sırta yayılan karın ağrısı, hipotansiyon ve soluk-terli görünüm rüptür/hemorajik şoku düşündürür.
- Yatak başı USG’de 7.2 cm AAA görülmesi acil vasküler onarım gerektiren anatomik kaynağı gösterir.

v185-new-223-ates-sarilik-ve-sag-ust-kadran-agrisi - Ateş, sarılık ve sağ üst kadran ağrısı: Acil ERCP ile biliyer drenaj

Karar kuralı: Ağır kolanjit + koledok taşı = antibiyotik/sıvı + acil ERCP drenajı.

- Ateş, sarılık ve sağ üst kadran ağrısı Charcot triadı ile akut kolanjiti düşündürür.
- Hipotansiyon ve konfüzyona eğilim ağır enfeksiyon ve organ perfüzyon riski oluşturur.
- USG’de koledok taşı ve dilatasyon kaynak kontrolü gerektiren mekanik biliyer obstrüksiyonu gösterir.

v185-new-224-ani-epigastrik-agri-ve-tahta-karin - Ani epigastrik ağrı ve tahta karın: Acil cerrahi değerlendirme, resüsitasyon ve perforasyon onarımı

Karar kuralı: Tahta karın ve subdiyafragmatik serbest hava = perforasyon; resüsitasyon + antibiyotik + acil cerrahi.

- NSAİİ kullanımı ve dispepsi öyküsü peptik ülser zeminini destekler.
- Ani başlayan ağrı ve tahta karın yaygın peritoniti gösterir.
- Diyafram altında serbest hava içi boş organ perforasyonu için cerrahi kaynak kontrolü gerektiren bulgudur.

v186-new-239-diskilama-sirasinda-siddetli-agri - Dışkılama sırasında şiddetli ağrı: Anal fissür

Karar kuralı: Cam kesiği tarzı dışkılama ağrısı ve posterior orta hat yırtık anal fissür için klasik ipucudur.

- Ağrının dışkılama sırasında cam kesiği tarzında olması anal fissür için tipiktir.
- Kabızlık sonrası az miktarda parlak kırmızı kanama distal anorektal yırtıkla uyumludur.
- Posterior orta hatta lineer yırtık görülmesi tanıyı doğrudan destekler.

v187-new-253-siddetli-karin-agrisi-ve-hafif-muayene-bulgusu - Şiddetli karın ağrısı ve hafif muayene bulgusu: Akut mezenter iskemi

Karar kuralı: Atrial fibrilasyon + pain out of proportion + laktat = akut mezenter iskemi düşün.

- Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülasyon embolik mezenter arter tıkanıklığı riskini artırır.
- Karın ağrısının muayene bulgularına göre orantısız şiddette olması akut mezenter iskemi için tipiktir.
- Laktat yüksekliği ve BT anjiyografide SMA dolum defekti bağırsak iskemisini destekler.

v188-new-268-epigastrik-agri-ve-lipaz-yuksekligi - Epigastrik ağrı ve lipaz yüksekliği: İntravenöz sıvı, analjezi, oral alımın düzenlenmesi ve yakın klinik izlem

Karar kuralı: Pankreatitte “lipaz yüksek = pankreatektomi/antibiyotik” değildir; komplikasyon yoksa destek tedavisi.

- Epigastrik ağrının sırta yayılması ve lipaz yüksekliği akut pankreatit tanısını destekler.
- USG’de koledok dilatasyonu ve sarılık olmaması acil ERCP gerektiren biliyer obstrüksiyonu desteklemez.
- Peritonit veya enfekte nekroz bulgusu olmadığı için başlangıç yaklaşımı destek tedavisidir.

v189-new-292-cilt-enfeksiyonunda-orantisiz-agri - Cilt enfeksiyonunda orantısız ağrı: Geniş spektrumlu antibiyotik ve acil cerrahi debridman

Karar kuralı: Orantısız ağrı ve toksisite varsa nekrotizan fasiit düşün; kaynak kontrolü acil debridmandır.

- Diyabet zemininde küçük kesi sonrası enfeksiyon hızla ilerlemiştir.
- Ağrının cilt bulgularına göre orantısız olması nekrotizan enfeksiyon için kritik ipucudur.
- Krepitasyon, yumuşak dokuda gaz ve laktat yüksekliği acil debridman gerektiren ağır tabloyu destekler.

v189-new-293-karin-sisligi-ve-gaz-cikaramama - Karın şişliği ve gaz çıkaramama: Fleksibl sigmoidoskopi ile endoskopik detorsiyon

Karar kuralı: Kahve çekirdeği + peritonit yok = fleksibl sigmoidoskopi ile detorsiyon.

- Karın distansiyonu, kabızlık ve gaz çıkaramama distal kolon obstrüksiyonunu düşündürür.
- Grafide kahve çekirdeği görünümü sigmoid volvulusu destekler.
- Peritonit ve laktat yüksekliği olmaması başlangıçta endoskopik detorsiyonu uygun kılar.

v189-new-294-supheli-tiroid-nodulu - Şüpheli tiroid nodülü: Ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi

Karar kuralı: Normal TSH + yüksek şüpheli ≥ 1 cm nodül = USG eşliğinde İİAB.

- Aile öyküsü ve çocuklukta radyasyon maruziyeti malignite riskini artırır.
- USG’de hipoekojenite, düzensiz sınır ve mikrokalsifikasyon yüksek şüphe bulgularıdır.
- TSH normal olduğundan düşük TSH’a yönelik sintigrafi yerine USG eşliğinde İİAB önceliklidir.

v194-new-327-yutma-sonrasi-agiza-gida-gelmesi - Yutma sonrası ağza gıda gelmesi: Zenker divertikülü

Karar kuralı: Yaşlı hasta + halitozis + sindirilmemiş gıda regürjitasyonu + aspirasyon = Zenker divertikülü.

- Sindirilmemiş gıdanın özellikle yatarken ağza gelmesi divertikül içinde gıda birikimini düşündürür.
- Halitozis ve tekrarlayan öksürük aspirasyon riskini destekler.
- Baryumlu grafide hipofarenks posteriorunda sakküler poş görülmesi Zenker divertikülünün anatomik bulgusudur.

v194-new-328-agrisiz-sarilik-ve-kilo-kaybi - Ağrısız sarılık ve kilo kaybı: Pankreas başı adenokarsinomu

Karar kuralı: Ağrısız sarılık + kilo kaybı + pankreas başı kitlesi = pankreas başı adenokarsinomu.

- Ağrısız sarılık, koyu idrar, akolik dışkı ve kilo kaybı malign distal biliyer obstrüksiyon düşündürür.
- Direkt bilirubin, ALP ve GGT yüksekliği ekstrahepatik kolestaz paternini gösterir.
- BT’de pankreas başında distal koledoku daraltan kitle görülmesi obstrüksiyonun anatomik nedenini ortaya koyar.

v195-new-355-kusma-sonrasi-gogus-agrisi - Kusma sonrası göğüs ağrısı: Ağızdan alımı kesmek, geniş spektrumlu antibiyotik başlamak ve acil cerrahi/endoskopik onarım değerlendirmek

Karar kuralı: Kusma sonrası göğüs ağrısı + subkutan amfizem = Boerhaave düşün; oral izlem değil acil perforasyon yönetimi.

- Ağrının güçlü kusma ataklarından sonra başlaması Boerhaave sendromu için tipik tetikleyicidir.
- Boyunda cilt altı krepatasyon özofagus perforasyonuna bağlı hava kaçağını düşündürür.
- BT’de distal özofagus komşuluğunda ekstraluminal hava, mediastinal sıvı ve plevral efüzyon perforasyonu destekler.

v195-new-356-kasik-altinda-agrili-sislik - Kasık altında ağrılı şişlik: İnkarlere femoral herni

Karar kuralı: İnguinal ligament altındaki ağrılı redükte edilemeyen kitle özellikle yaşlı kadında femoral herni düşündürür.

- Kitle inguinal ligamentin altında ve pubik tüberkülün lateral-inferiorunda yerleşmiştir.
- Şişliğin hassas ve redükte edilemez olması inkarsere fıtık lehinedir.
- USG’de femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi görülmesi femoral herni tanısını destekler.

v195-new-357-erken-evre-meme-kitlesi - Erken evre meme kitlesi: Sentinel lenf nodu biyopsisi

Karar kuralı: Erken evre invaziv meme kanseri + klinik nod negatif aksilla = sentinel lenf nodu biyopsisi.

- Kor biyopsi invaziv duktal karsinomu doğrulamıştır.
- Tümör küçük ve erken evre bağlamındadır.
- Aksillada klinik ve ultrasonografik patolojik lenf nodu izlenmemesi sentinel lenf nodu biyopsisini uygun kılar.